Prise en charge des Infections Génitales Hautes

A partir des Recommandations pour la Pratique Clinique élaborées par le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) en collaboration avec la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF)

Diaporama réalisé par le groupe Recommandations de la SPILF le 8 janvier 2020

Définitions

- Les IGH regroupent les endométrites, salpingites, collections purulentes et pelvipéritonites d'origine génitale.
- Classification:
  - IGH non compliquées
    - simples: compatibles avec une prise en charge en externe
    - intermédiaires: nécessitant une hospitalisation pour incertitude diagnostique, hyperalgie, difficulté de prise orale du traitement, échec d'un traitement antérieur, détresse psycho-sociale
  - IGH compliquées: abcès tuboovarien (ATO) ou pelvipéritonite nécessitant une intervention

Diagnostic clinique

- Circonstances favorisantes:
  - facteurs de risque d'infection sexuellement transmissible (IST):
    - ≤ 25 ans, antécédent IST, nb partenaires ≥ 2 dans l'année, changement partenaire récent ou diagnostiqué avec IST
  - manœuvres endo-utérines, post-abortum, post-partum
- Diagnostic positif: douleur annexielle provoquée ou douleur à la mobilisation utérine
- Fièvre, leucorrhées, métrorragies renforcent la probabilité diagnostique.
- L'association à un syndrome rectal doit faire évoquer un abcès du Douglas

Diagnostic paraclinique (1)

- En cas de suspicion d'IGH, NFS et CRP sont conseillées:
  - L'absence d'hyperleucocytose ou une CRP normale ne permettent pas d'éliminer le diagnostic d'IGH
  - Une hyperleucocytose associée à une élévation de la CRP doit faire évoquer une forme compliquée ou un diagnostic différentiel (ex: appendicite aiguë)
- L'échographie pelvienne:
  - Est recommandée pour rechercher une IGH compliquée ou un diagnostic différentiel.
  - Sa normalité n'élimine pas le diagnostic d'IGH non compliquée
  - Elle ne doit pas retarder l'antibiothérapie.

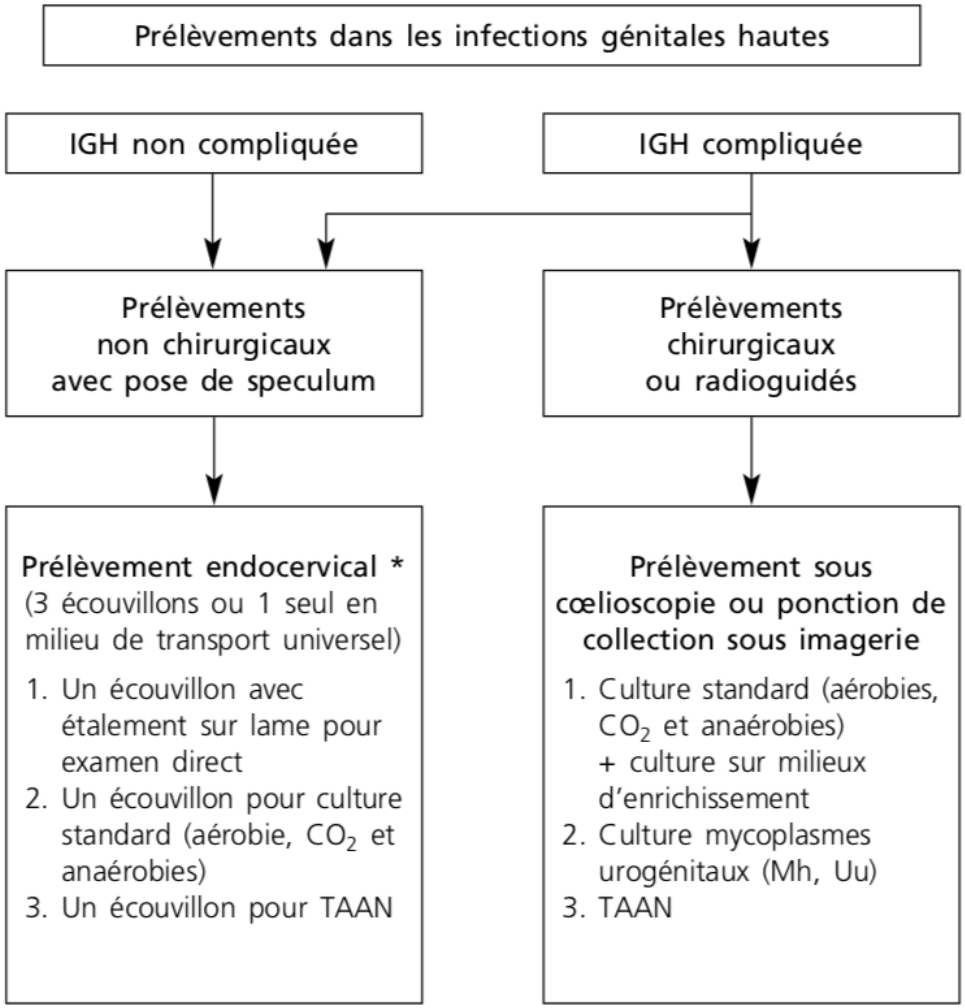
Diagnostic paraclinique (2)

- La TDM ou l’IRM ne sont indiquées que pour le diagnostic différentiel.
- La cœlioscopie n’est pas recommandée pour le diagnostic d’IGH.

Bactéries impliquées

- Agents des IST : *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Mycoplasma genitalium*
- Bactéries de la dysbiose vaginale ou vaginose bactérienne: *Gardnerella vaginalis*, *Atopobium spp*, *Sneathia spp*, anaérobies (*Prevotella spp*,...)
- Bactéries de la flore vaginale: entérobactéries, *Haemophilus spp*, streptocoques, staphylocoques ...

Diagnostic microbiologique



CT : *Chlamydia trachomatis* ; MG : *Mycoplasma genitalium* ; NG : *Neisseria gonorrhoeae* ; TAAN : technique d'amplification des acides nucléiques ; Mh : *Mycoplasma hominis* ; Uu : *Ureaplasma urealyticum*

* Dans les situations où la pose d'un speculum n'est pas possible, des prélèvements vaginaux seront réalisés par défaut.

- La négativité des prélèvements n'exclut pas le diagnostic d'IGH

- La sérologie *C. trachomatis* n'a pas d'intérêt dans le diagnostic d'IGH

- Le prélèvement sans spéculum n'est validé que pour le diagnostic des IST.

Traitement des IGH

- Le traitement antibiotique doit être débuté dès lors que le diagnostic est probable et après réalisation des prélèvements microbiologiques.
- Le retard thérapeutique est associé à une augmentation des risques de grossesse extra-utérine et d’infertilité tubaire.

Traitement des IGH non compliquées simples

	Antibiotiques	Posologie	Voie	Durée
Externe 1ère intention	Ceftriaxone + Doxycycline + Métronidazole	1 g 100 mg x 2/j 500 mg x 2/j	IM/IV PO PO	1 fois 10 j 10 j
Externe alternatives	Ofloxacine + Métronidazole +/-Ceftriaxone*	200 mg x 2/j 500 mg x 2/j 1 g	PO PO IM/IV	10 j 10 j 1 fois
	Lévofloxacine + Métronidazole +/-Ceftriaxone*	500 mg x 1/j 500 mg x 2/j 1 g	PO PO IM/IV	10 j 10 j 1 fois
	Moxifloxacine ** +/- Ceftriaxone*	400 mg x 1/j 1 g	PO IM/IV	**10 j** **1 fois**

*Ceftriaxone si *N. gonorrhoeae* résistant aux fluoroquinolones.
**Utilisation nécessitant de vérifier l'ECG (conditions pro-arythmogènes) et l'absence de médicaments allongeant le QT.

Antibiothérapie des IGH intermédiaires: (voir diapo suivante)

	Antibiotiques	Posologie	Voie
Induction en hospitalisation: 1ère intention	Ceftriaxone +Doxycycline* +Métronidazole*	1 à 2 g /j 100 mg x 2/j 500 mg x 3/j	IV IV, PO IV, PO
Induction en hospitalisation: alternatives	Céfoxitine +Doxycycline	2 g x4/j 100 mg x 2/j	IV IV, PO
	Clindamycine +Gentamicine	600 mg x 4/j 5 mg/kg x 1/j	IV IV
Relais oral	Doxycycline +Métronidazole	100 mg x 2/j 500 mg x 3/j	PO PO
	Clindamycine	600 mg x 3 /j	PO
	Ofloxacine +Métronidazole	200 mg x 3/j 500 mg x 3/j	PO PO
	Lévofloxacine +Métronidazole	500 mg x 1/j 500 mg x 3/j	PO PO
	Moxifloxacine	400 mg x 1/j	PO

* la biodisponibilité orale autorise la voie orale

Position de la SPILF

- La place de la clindamycine doit être limitée:
  - en raison de l'évolution des résistances
  - de sa très faible activité sur les bacilles à Gram négatif
  - et de la toxicité de l'association aux aminosides
- Pour le traitement d'induction, en cas d'allergie vraie à la pénicilline avec réaction anaphylactique ou d'allergie aux céphalosporines, l'alternative proposée est:
  - fluoroquinolone + métronidazole

Suivi d'une IGH non compliquée

- En traitement externe, la patiente doit être revue entre J3 et J5 afin de vérifier l'évolution clinique, la tolérance et l'observance du traitement et les résultats microbiologiques.
- La détection de *N. gonorrhoeae* ou de *M. genitalium* nécessite de vérifier la cohérence du traitement initial.
  - Si *N. gonorrhoeae* résistant aux fluoroquinolones et traitement sans ceftriaxone: recours à la ceftriaxone.
  - Si *M. genitalium*, traitement par azithromycine (J1 500 mg, puis 250 mg/j jusqu'à J5) ou moxifloxacine.
- Un examen microbiologique par TAAN sur prélèvement vaginal à la recherche d'IST est recommandé 3 à 6 mois après une IGH

Traitement des IGH compliquées

- Tout ATO ≥ 3 à 4 cm doit être drainé (ponction guidée par imagerie ou cœlioscopie)
- Les IGH compliquées graves sont: la rupture d'abcès, la péritonite généralisée et le choc septique.
- En cas de forme grave, chirurgie en urgence après instauration d'une antibiothérapie (un aminoside doit être associé au schéma thérapeutique en cas de choc septique).
- En cas de mise en évidence d'une bactérie non incluse dans le spectre de l'antibiothérapie initiale, une adaptation doit être discutée.
- La durée totale de l'antibiothérapie est de 14 j.

Antibiothérapie des IGH compliquées: (voir diapo suivante)

	Antibiotiques	Posologie	Voie
Induction en hospitalisation: 1ère intention	Ceftriaxone** +Doxycycline*** +Métronidazole***	1 à 2 g /j 100 mg x 2/j 500 mg x 3/j	IV IV, PO IV, PO
Induction en hospitalisation: alternatives	Céfoxitine +Doxycycline	2 g x4/j 100 mg x 2/j	IV IV, PO
	Clindamycine +Gentamicine*	600 mg x 4/j 5 mg/kg x 1/j	IV IV
Relais oral	Doxycycline +Métronidazole	100 mg x 2/j 500 mg x 3/j	PO PO
	Clindamycine	600 mg x 3 /j	PO
	Ofloxacine +Métronidazole	200 mg x 3/j 500 mg x 3/j	PO PO
	Lévofloxacine +Métronidazole	500 mg x 1/j 500 mg x 3/j	PO PO
	Moxifloxacine	400 mg x 1/j	PO

* Formes graves: gentamicine 5 mg/kg x 1/j adaptée à fonction rénale et durée ≤ 5 j.

** 2 g si sepsis ou signe de gravité et/ou P> 80 kg; *** la biodisponibilité orale autorise la voie orale

Position de la SPILF

- La gentamicine n’est indiquée qu’en cas de choc septique à une posologie de 5 à 7 mg/kg/j pour une durée maximale de 3 j.
- La place de la clindamycine doit être limitée:
  - en raison de l’évolution des résistances
  - de sa très faible activité sur les bacilles à Gram négatif
  - et de la toxicité de l’association aux aminosides
- Pour le traitement d’induction, en cas d’allergie vraie à la pénicilline avec réaction anaphylactique ou d’allergie aux céphalosporines, l’alternative proposée est:
  - fluoroquinolone + métronidazole

IGH et dispositif intra-utérin (DIU)

- En cas d'IGH non compliquée sur DIU, le retrait du DIU ne s'impose pas de façon systématique.
- Le retrait doit être discuté:
  - Dans les formes compliquées,
  - Ou en cas d'évolution défavorable au-delà de 3 jours suivant le début de l'antibiothérapie.

CAS DES IGH DU POST-PARTUM- HORS ISO

IGH du post-partum: diagnostic

- Signes d’appel: douleurs abdomino-pelviennes, fièvre et/ou lochies fétides
- Douleur utérine provoquée et température ≥ 38°C

...ein du post-partum: traitement (1) voir diapo suivante

- En 1ère intention:
  - amoxicilline-acide clavulanique 3 à 6 g/j selon le poids, IV ou PO, jusqu'à 48 h de l'apyrexie et de la disparition des douleurs provoquées.
- En cas d'allergie vraie à la pénicilline avec réaction anaphylactique :
  - Clindamycine 600 mg x 3/ j IV associée à gentamicine 5 mg/kg x 1 /j IV .

.

Position de la SPILF

- La place de la clindamycine doit être limitée:
  - en raison de la prévalence des résistances (streptocoques, anaérobies)
  - de sa très faible activité sur les bacilles à Gram négatif
  - et de la toxicité de l'association aux aminosides
  - elle est déconseillée en cas d'allaitement
- En cas d'allergie vraie à la pénicilline avec réaction anaphylactique ou d'allergie aux céphalosporines, l'alternative proposée est:
  - lévofloxacine + métronidazole (y compris allaitement - CRAT)

IGH du post-partum: traitement (2)

- En cas de fièvre persistante sous antibiothérapie adaptée, réaliser une TDM ou une IRM avec injection de produit de contraste à la recherche d'une thrombophlébite ou d'un abcès profond.
- En cas de thrombophlébite pelvienne, une anticoagulation par héparine doit être prescrite; la durée de l'anticoagulation est habituellement de 6 semaines.

PREVENTION DES IGH

Prévention des IGH (1)

- Césarienne:
  - Antibioprophylaxie, 30 mn avant incision, par céfazoline 2 g IV ou céfuroxime 1,5 g IV; dose à doubler si P> 100 kg ou IMC avant grossesse > 35 kg/m^2.
  - En cas d'allergie vraie aux pénicillines avec réaction anaphylactique ou d'allergie aux céphalosporines : clindamycine 900 mg sur 1 h avec surveillance continue de l'ECG maternel
- Hystérosalpingographie:
  - Pas d'antibioprophylaxie systématique,
  - Dépistage des infections à *C. trachomatis* et *N. gonorrhoeae* chez les femmes à risque d'IST.

Prévention des IGH (2)

- Hystéroscopie diagnostique ou opératoire: pas d'antibioprophylaxie.
- Pose de DIU:
  - Pas d'antibioprophylaxie,
  - Dépistage des infections à *C. trachomatis* et *N. gonorrhoeae* en cas de risque d'IST.
- Délivrance artificielle: pas d'antibioprophylaxie; asepsie chirurgicale.
- IVG:
  - Pas d'antibioprophylaxie pour les IVG médicamenteuses
  - Pour les IVG chirurgicales, pas de consensus; position de la SPILF et la SFAR: pas d'antibioprophylaxie
  - Dépistage des infections à *C. trachomatis* et *N. gonorrhoeae*